Diarreia aguda no adulto

Resumo de estudo para raciocínio clínico — integra quatro revisões do UpToDate (2025–2026)

Sigla no texto	Fonte (citada apenas por nome)
[Abund.]	UpToDate — Approach to the adult with acute diarrhea in resource-abundant settings (LaRocque, Harris; atualizado em 07/04/2026)
[Limit.]	UpToDate — Approach to the adult with acute diarrhea in resource-limited settings (LaRocque, Pietroni, Chisti; atualizado em 26/09/2025)
[Salm.]	UpToDate — Nontyphoidal Salmonella: Gastrointestinal infection and asymptomatic carriage (Hohmann; atualizado em 29/07/2026)
[TRO]	UpToDate — Oral rehydration therapy (Freedman; atualizado em 06/08/2025)
[Externo: ...]	Dado que não consta nas quatro fontes (posologia, efeito adverso, protocolo brasileiro), identificado com o nome da fonte consultada
Elaborado	Figura, tabela ou prescrição montada a partir das fontes; não consta na fonte nesse formato

1. Contextualização

A diarreia aguda é, no adulto saudável de países com mais recursos, uma “doença incômoda” que quase sempre se resolve com medidas de suporte; ao mesmo tempo, a doença diarreica segue entre as principais causas de morte no mundo [Abund.]. O valor deste material está em dois pontos de decisão que a fonte destaca: **quando pedir exame de fezes** e **quando iniciar antibiótico empírico**. A maioria dos casos é infecciosa e provavelmente viral; por isso a maior parte dos pacientes não precisa nem de coprocultura nem de antibiótico, e o tratamento central é a **reidratação, de preferência por via oral** [Abund.][TRO].

O que muda na prática: (1) separar o paciente com gravidade, sinais inflamatórios ou risco do hospedeiro daquele que só precisa de suporte; (2) saber que antibiótico tem custo real — resistência, risco de *C. difficile*, prolongamento da eliminação de *Salmonella* e, em infecção por *E. coli* produtora de toxina Shiga (STEC), associação com síndrome hemolítico-urêmica; (3) usar a solução de reidratação oral (SRO) com mais frequência do que se faz habitualmente — o texto afirma que a terapia de reidratação oral é subutilizada nos EUA, onde há tendência a usar hidratação IV em excesso [Abund.][TRO].

> **Nota de leitura crítica:**
> As quatro fontes são revisões narrativas de especialistas, não ensaios clínicos. As recomendações com graduação da própria fonte são, em sua maioria, 2B ou 2C (confiança baixa a moderada); apenas a não prescrição de antibiótico na diarreia aquosa sem gravidade (Grade 1B) e a SRO como primeira linha na desidratação leve a moderada (Grade 1A) têm recomendação forte. O texto de TRO é centrado em crianças e extrapola para adultos “com ajustes”.

Conflitos de interesse declarados pelas fontes (todos considerados “mitigados” pelo UpToDate): LaRocque — apoio de pesquisa do CDC e do NIH; Hohmann — apoio de pesquisa e consultoria ligados a *C. difficile*/microbioma e a COVID-19; Freedman (TRO) — palestrante (*speaker’s bureau*) de empresa farmacêutica sobre terapia de reidratação oral, tema da própria revisão. Os demais autores e editores declaram não ter conflitos relevantes.

2. Epidemiologia e condições facilitadoras

- **Mundo:** a doença diarreica causou 1,2 milhão de mortes em 2021 (2,9 milhões em 1990); cerca de 5 bilhões de casos por ano; maior mortalidade na África subsaariana e no Sul da Ásia; mais de 2,2 bilhões de pessoas sem acesso a água potável segura em 2022 [Limit.]. A queda da mortalidade é atribuída a saneamento, SRO e vacina contra rotavírus [Limit.][TRO].
- **Países com mais recursos:** em 2022 o FoodNet (EUA) registrou 25.479 casos, 5.981 hospitalizações e 170 mortes por infecções transmitidas por alimentos. A maioria das diarreias infecciosas é provavelmente viral — coproculturas são positivas em só 1,5 a 5,6% dos casos; entre adultos saudáveis com diarreia grave (≥4 evacuações líquidas/dia por mais de 3 dias), um patógeno bacteriano foi identificado em 87% (estudo com 173 pacientes) [Abund.]. A frequência real está provavelmente subestimada, pois muitos não procuram atendimento nem são testados [Abund.].

- **Salmonella não tifoide:** causa importante de diarreia no mundo e uma das principais causas de doença de origem alimentar nos EUA; sorotipos frequentes: Enteritidis, Newport e Typhimurium [Salm.].
- **Dado brasileiro de prevalência/incidência:** não informado na fonte.

2.1 Quadro de classificação dos tipos de diarreia

Quadro elaborado a partir de [Abund.], [Limit.], [TRO] e [Salm.] — não consta na fonte nesse formato. Cada eixo responde a uma pergunta clínica diferente; um mesmo paciente é classificado em todos eles ao mesmo tempo (ex.: diarreia aguda, inflamatória, de cólon, infecciosa).

Eixo	Tipo	Critério	Como reconhecer / exemplos	O que muda na conduta
Duração	Aguda	≤14 dias	Maioria infecciosa e autolimitada	Reposição de volume; exame de fezes só se houver indicação
	Persistente	14 a 30 dias	Parasitas (ex.: *Giardia*, *Cryptosporidium*) tornam-se mais prováveis	Pesquisa de parasitas e de *C. difficile*; considerar causas não infecciosas
	Crônica	>30 dias	Causas não infecciosas predominam (ex.: DII, má absorção, medicamentos); tema de revisão separada nas fontes	Investigação de causa não infecciosa [Abund.]
Aspecto das fezes	Aquosa (não inflamatória)	Fezes líquidas, volumosas, sem sangue; febre ausente ou baixa	Cólera, ETEC, rotavírus, norovírus, *Giardia*	Hidratação é o tratamento; antibiótico em geral não
	Inflamatória	Sangue, fezes mucoides de pequeno volume, febre, tenesmo	*Shigella*, *Salmonella*, *Campylobacter*, STEC, *E. histolytica*, *C. difficile*	Considerar antibiótico (exceto STEC); coletar fezes
	Disenteria	Diarreia com sangue visível	Shigelose; amebíase; STEC (sem febre)	Antibiótico imediato em recursos limitados; reter se suspeita de STEC
Sítio	Intestino delgado	Grande volume, aquosa, sem sangue; náusea, cólica periumbilical	Cólera, ETEC, rotavírus	Maior risco de desidratação
	Cólon	Pequeno volume, urgência, tenesmo, sangue/muco	*Shigella*, *Campylobacter*, STEC, amebíase	Maior risco de complicações invasivas e imunomediadas
Mecanismo	Secretória	Secreção ativa de água/eletrólitos pelo enterócito (enterotoxina)	Cólera: diarreia secretória por enterotoxina	O cotransporte Na^+-glicose segue funcionante → SRO
	Invasiva/inflamatória	Invasão e lesão da mucosa com resposta inflamatória	Shigella, Salmonella, Campylobacter, E. histolytica	Investigar e tratar conforme agente
	Má absorção/osmótica	Soluto não absorvido retém água no lúmen	Má absorção secundária de lactose após gastroenterite; bebidas muito açucaradas. Classificação osmótica detalhada: não informada na fonte	Evitar lácteos (exceto iogurte) e bebidas hiperosmolares
Causa	Infecciosa	Vírus, bactérias, protozoários	Vírus são a causa mais provável na maioria; bactérias em 87% dos casos graves selecionados [Abund.]	Ver seções 4.3 e 5
	Não infecciosa	Medicamentos, DII, isquemia, doença do enxerto contra o hospedeiro, etc.	Mais comum quanto mais persistente a diarreia; também em diarreia aguda com antibiótico/quimioterapia	Suspeitar se persistir ou se exame negativo
Contexto	Do viajante / associada a serviços de saúde	Viagem a local de recursos limitados; antibiótico ou internação nos últimos 3 meses	ETEC e outros (viajante); *C. difficile* (associada a serviços de saúde)	Orienta exame de fezes e antibiótico empírico

Fatores de risco e condições facilitadoras (organizados como no raciocínio de tutoria):

Idade, sexo, etnia	História familiar e genética	Hábitos, exposições e medicamentos	Comorbidades
Extremos de idade; idade ≥70 anos = hospedeiro de risco [Abund.]. Para Salmonella invasiva: lactentes <12 meses e adultos >50 anos [Salm.]. Sexo e etnia: não informado na fonte.	Não informado na fonte.	Alimentos crus ou mal cozidos, laticínios não pasteurizados; contato com animais (aves, tartarugas, répteis, zoológicos); creche; viagem a locais de recursos limitados; sexo anal/oro-anal (HSH); piscinas e água recreacional; **antibiótico ou internação nos últimos 3 meses** (*C. difficile*); inibidores de bomba de prótons e supressão ácida; quimioterapia [Abund.]. Aglomeração e saneamento precário (campos de refugiados) [Limit.].	Imunossupressão (HIV avançado, transplante, corticoide); doença inflamatória intestinal (DII); gestação (listeriose cerca de 20 vezes mais provável); cirrose (*Vibrio*); hemocromatose/talassemia (*Yersinia*); cardiopatia e aterosclerose/próteses (Salmonella invasiva); hemoglobinopatias [Abund.][Salm.].

3. Fisiopatologia

Definição e mecanismo geral. Diarreia é a passagem de fezes amolecidas ou líquidas, tipicamente ≥3 vezes em 24 h; reflete aumento do conteúdo de água, por **má absorção** e/ou **secreção ativa** de água pelo intestino [Abund.]. A absorção passiva de água depende de três mecanismos: trocadores sódio/hidrogênio, gradiente eletroquímico e **cotransporte de sódio com solutos orgânicos (como a glicose)**; a falha de qualquer um produz diarreia, mas nas gastroenterites infecciosas o cotransporte sódio-glicose permanece intacto [TRO].

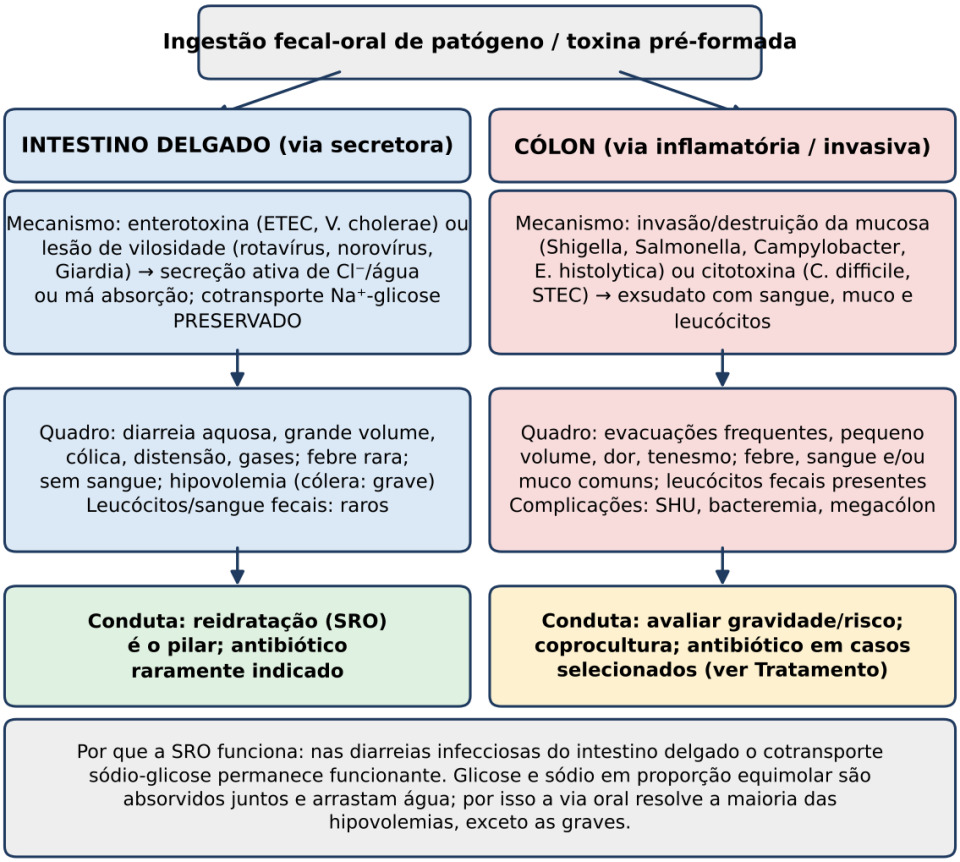


Figura 1. Do patógeno ao quadro clínico: via secretora (intestino delgado) versus via inflamatória/invasiva (cólon), e a base fisiológica da SRO. *Elaborada a partir de [Abund.] (Tabela 2, texto sobre origem da diarreia), [Limit.] e [TRO] — não consta na fonte nesse formato.*

3.1 Sítio de acometimento e patógenos

Grupo	Intestino delgado (aquosa, grande volume)	Cólon (inflamatória; sangue/muco; pequeno volume)
Bactérias	Salmonella*, E. coli†, C. perfringens, S. aureus, Aeromonas hydrophila, B. cereus, V. cholerae	Campylobacter*, Shigella, C. difficile, Yersinia, V. parahaemolyticus, E. coli enteroinvasiva, Plesiomonas shigelloides, Klebsiella oxytoca (rara)

Grupo	Intestino delgado (aquosa, grande volume)	Cólon (inflamatória; sangue/muco; pequeno volume)
Vírus	Rotavírus, norovírus, astrovírus	Citomegalovírus*, adenovírus, herpes simples
Protozoários	Cryptosporidium*, Microsporidium*, Cystoisospora, Cyclospora, Giardia lamblia	Entamoeba histolytica

* Pode acometer delgado e cólon; listado onde é mais provável. † EPEC, EAEC, EHEC e ETEC podem contribuir; coproculturas de rotina não os distinguem da E. coli da flora normal. Fonte: [Abund.] Tabela 2.

3.2 Mecanismos específicos citados nas fontes

- **Cólera:** doença secretora causada por enterotoxina de *V. cholerae* (sorogrupo O1 historicamente; O139 desde 1992, restrito a poucos países da Ásia); dose infectante alta (10^3 a 10^6 organismos) [Limit.].
- **Shigella:** dose infectante muito baixa (10 a 100 organismos), o que favorece a transmissão pessoa a pessoa e grandes epidemias; resistência antimicrobiana crescente [Limit.]. A hiponatremia frequente pode dever-se à secreção inapropriada de ADH [Limit.].
- **STEC:** as toxinas Shiga lesam o endotélio e causam síndrome hemolítico-urêmica (SHU) [Limit.]. O tratamento antibiótico associa-se ao desenvolvimento de SHU, sobretudo com beta-lactâmicos [Abund.].
- **Toxinas pré-formadas** (*S. aureus*, *B. cereus*) produzem vômitos em até 6 h; *C. perfringens*, 8 a 16 h [Abund.].
- **Entamoeba histolytica** destrói leucócitos: sangue nas fezes sem leucócitos fecais sugere amebíase [Abund.].
- **Salmonella:** dose ingerida maior correlaciona-se com gravidade, duração e perda de peso [Salm.]. O antibiótico pode prolongar a eliminação fecal — provável efeito deletério sobre o microbioma, que contribui para a resistência à colonização [Salm.].

Conexão mecanística:
Por que o cotransporte preservado importa: como a absorção de sódio acoplada à glicose continua funcionando, uma solução com glicose e sódio em proporção equimolar (1:1) arrasta água para dentro do enterócito mesmo com secreção ativa em curso. Isso explica por que a SRO é tão eficaz quanto a hidratação IV na hipovolemia por gastroenterite e quando ela deixa de funcionar: íleo, má absorção intrínseca (intestino curto), vômitos incoercíveis ou hipovolemia grave [TRO]. Veja a aplicação na seção 6.

Conexão mecanística:
Bebidas com excesso de glicose em relação ao sódio (suco de maçã, refrigerante, bebida esportiva) aumentam a osmolaridade luminal e, teoricamente, as perdas; o caldo de galinha tem sódio em excesso sem glicose para transportá-lo e pode causar hipernatremia [TRO]. Quando a osmolaridade da SRO foi reduzida (OMS, 2002: de 311 para 245 mOsm/L, glicose de 111 para 75 mmol/L e sódio de 90 para 75 mEq/L) houve menor volume e menor duração da diarreia, e a necessidade de IV suplementar caiu 33% [TRO][Limit.].

Fármacos e mecanismo (resumo): a *loperamida* reduz a motilidade; por reter líquido na luz pode **mascarar a perda hídrica** e prolongar doença invasiva. O *racecadotril* é inibidor de encefalinase (antissecretor). O *subsalicilato de bismuto* é uma alternativa quando há febre/disenteria, mas é salicilato [Abund.]. Detalhes na seção 7.

Por que isso importa clinicamente:
A fisiopatologia dá a regra de decisão: diarreia secretora (aquosa) = repor volume e esperar; diarreia inflamatória (sangue, muco, febre) = pensar em invasão/citotoxina, avaliar gravidade e hospedeiro, testar fezes e, em casos selecionados, tratar. Sangue visível é o achado que muda a conduta (STEC, Shigella, Campylobacter, ameba, causas não infecciosas) [Abund.].

4. Apresentação clínica

4.1 Definições e quadro típico

Termo	Definição
Diarreia	≥3 evacuações amolecidas ou líquidas em 24 h
Aguda	≤14 dias (a fonte de recursos limitados usa “<14 dias”)
Persistente	>14 e <30 dias
Crônica	>30 dias

Termo	Definição
Disenteria (diarreia invasiva)	Diarreia com sangue ou muco visíveis ([Abund.]); [Limit.] define apenas com sangue visível. Costuma associar-se a febre e dor abdominal

- **Origem no delgado:** diarreia aquosa, de grande volume, com cólica, distensão e gases; febre rara; sangue oculto e células inflamatórias raros; perda de peso se persistir.
- **Origem no cólon:** evacuações frequentes, regulares, de pequeno volume e dolorosas; febre e fezes com sangue ou muco comuns; hemácias e células inflamatórias à microscopia [Abund.].
- **Salmonella não tifoide:** incubação de 8 a 72 h; diarreia, náusea, vômito, febre, cólica, mal-estar e cefaleia; em geral sem sangue franco (mais comum em crianças); febre cede em 48–72 h e a diarreia em 4–10 dias; a mediana de eliminação intermitente nas fezes é de cerca de 5 semanas. Clinicamente indistinguível de outras gastroenterites [Salm.].
- **Cólera:** início súbito, vômitos e cólica sem dor intensa nem tenesmo; febre incomum; fezes em “água de arroz” com flocos de muco em adulto francamente desidratado (Figura 2) [Limit.].
- **Shigelose:** evacuações líquidas pequenas e frequentes com sangue, com ou sem muco; cólicas, tenesmo, febre e anorexia [Limit.].
- **Síndromes que começam com diarreia e evoluem com febre, cefaleia e mialgias** devem levantar tifoide (viajantes) ou *Listeria monocytogenes* (especialmente com rigidez de nuca ou em gestantes) [Abund.].

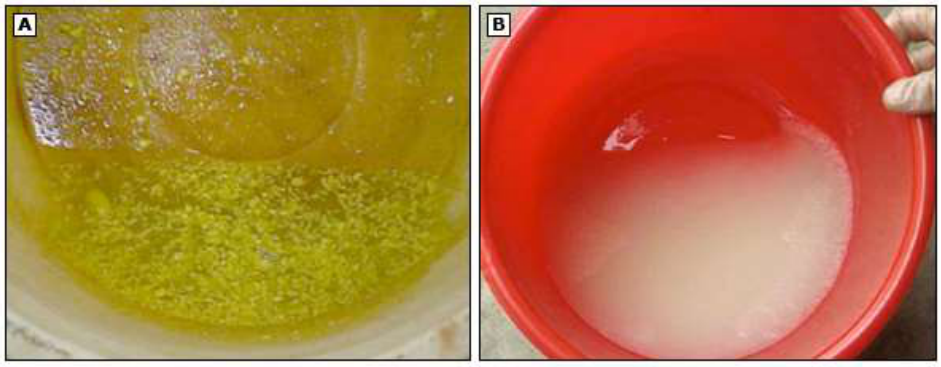


Figura 2. Diarreia aquosa aguda (<14 dias, sem sangue visível). (A) Fezes verdes e aquosas, frequentes na gastroenterite por rotavírus. (B) Fezes em “água de arroz”, características da cólera grave. *Extraída de [Limit.] (Picture 1); texto original da figura em inglês.*

4.2 O que perguntar na anamnese

Pergunta	Por que muda a probabilidade
Duração, frequência e aspecto das fezes (aquosa × sangue/muco); febre; dor; vômitos	Separa via secretora de inflamatória e define gravidade
Volume: urina escura ou escassa, tontura ao levantar, sede	Define a prioridade: reposição; indica painel metabólico
Tempo entre a refeição suspeita e o início	≤6 h: toxina pré-formada de *S. aureus*/*B. cereus* (náusea e vômito iniciais); 8–16 h: *C. perfringens*; >16 h: vírus ou bactéria (ETEC, STEC e outros)
Alimentos: laticínios não pasteurizados, carne/peixe crus, aves, ovos, suplementos “orgânicos”	Orienta patógeno (Tabela 1) e necessidade de meios de cultura especiais
Viagem recente e remota; moradia; ocupação; animais de estimação e hobbies; creche	Viagem a locais de recursos limitados aumenta diarreia bacteriana e certos parasitas; creche: Shigella, Cryptosporidium, Giardia; animais: Salmonella
Antibiótico, internação ou quimioterapia nos últimos 3 meses; IBP	*C. difficile*; IBP aumenta o risco de diarreia infecciosa
Antecedentes: imunossupressão, gestação, cirrose, hemocromatose, DII, HSH	Hospedeiro de risco; patógenos específicos (*Listeria*, *Vibrio*, *Yersinia*, parasitas)

4.3 Patógenos, incubação e pistas epidemiológicas

Patógeno	Incubação média	Alimentos/fontes clássicos	Pistas epidemiológicas
Aquosa — Norovírus	24–48 h	Frutos do mar, alimentos prontos, vegetais, frutas	Surtos em restaurantes, serviços de saúde, escolas/creches, cruzeiros e quartéis
C. difficile	—	—	Antibiótico, internação, quimioterapia, supressão ácida, DII

Patógeno	Incubação média	Alimentos/fontes clássicos	Pistas epidemiológicas
C. perfringens	8–16 h	Carne, aves, molhos, conservas caseiras	—
E. coli enterotoxigênica (ETEC)	1–3 dias	Água/alimento com contaminação fecal	Viagem a locais de recursos limitados
Outros vírus (rotavírus, adenovírus entérico, astrovírus, sapovírus)	10–72 h	Água/alimento com contaminação fecal	Creches; imunocomprometidos; rotavírus diminuiu onde há vacina infantil
Giardia lamblia	7–14 dias	Água/alimento com contaminação fecal	Creches, piscinas, trilhas/camping (água com castores)
Cryptosporidium	2–28 dias	Vegetais, frutas, leite não pasteurizado	Creches; piscinas e água recreacional
Listeria monocytogenes	1 dia (gastroenterite)	Frios e embutidos, queijos moles, patês, frutas	Gestação (risco ~20×), imunossupressão, extremos de idade
Cyclospora	1–11 dias	Frutas vermelhas e ervas importadas	—
Inflamatória — Salmonella não tifoide	1–3 dias	Aves, ovos, vegetais, carne, peixe, leite/suco sem pasteurização, pastas de oleaginosas, especiarias	Contato com animais (répteis, aves, zoológicos)
Campylobacter	1–3 dias	Aves, carne, leite não pasteurizado	Viagem
Shigella	1–3 dias	Vegetais crus	Creches, aglomeração, HSH, viagem
E. coli produtora de toxina Shiga (STEC)	1–8 dias	Carne moída, vegetais, leite e suco não pasteurizados	Creches, asilos, extremos de idade
Yersinia	4–6 dias	Carne de porco, água não tratada	Cirrose, hemocromatose, talassemia; transfusão
Vibrio parahaemolyticus	1–3 dias	Frutos do mar crus	Cirrose
Entamoeba histolytica	1–3 semanas	Água/alimento com contaminação fecal	Viagem a locais de recursos limitados, HSH

Patógenos classicamente inflamatórios também podem causar diarreia aquosa no início; *C. difficile* pode se apresentar como inflamatória. Fonte: [Abund.] Tabelas 1 e 3; pistas de contexto também do texto da seção “Exposições”.

4.4 Exame físico

- **Volemia:** mucosas secas, turgor diminuído, hipotensão postural ou franca, alteração do sensório; os sinais podem ser leves ou ausentes na hipovolemia inicial [Abund.].
- **Abdome:** procurar íleo e peritonite — distensão, dor à percussão suave, rigidez, descompressão brusca dolorosa [Abund.].

Exame (adulto)	Hipovolemia leve	Hipovolemia moderada	Hipovolemia grave
Estado mental	Alerta	Inquieto, irritável	Letárgico ou inconsciente
Olhos / lágrimas	Normais / presentes	Fundos / ausentes	Muito fundos e secos / ausentes
Boca e língua	Úmidas ou levemente secas	Secas	Muito secas
Sede	Sede aumentada	Sedento, bebe avidamente	Bebe mal ou não consegue beber
Turgor (prega cutânea)	Volta rápido	Volta devagar	Volta muito devagar
Pulso	Normal	Rápido, fraco	Muito rápido e fraco ou impalpável
Perda de volume	<5% do peso	5–10% do peso	>10% do peso
Déficit estimado	<50 mL/kg	50–100 mL/kg	>100 mL/kg

Fonte: [Limit.] Tabela 4. A OMS chama as três categorias de “sem desidratação”, “alguma desidratação” e “desidratação grave”. Em crianças, [TRO] usa 3–5%, 6–9% e ≥10%; como os sinais de leve e moderada se sobrepõem, os especialistas agrupam ambas como “alguma desidratação” e as tratam igual.

4.5 Gravidade para fins de decisão

Critério	Definição na fonte
Doença grave (para testar fezes e considerar antibiótico) [Abund.]	Febre ≥38,5 °C, sinais de hipovolemia, ≥6 evacuações não formadas/24 h, dor abdominal intensa (o texto usa “>6” em um trecho e “≥6” nos demais, e “hospitalização” em um resumo)
Hospedeiro de alto risco [Abund.]	Idade ≥70 anos; comorbidades (cardiopatia — pode piorar com hipovolemia ou infusão rápida); imunossupressão (inclui HIV avançado); DII; gestação
Salmonelose grave [Salm.]	>9–10 evacuações/dia, febre alta ou persistente, necessidade de internação

SINAIS DE ALARME

- **Hipovolemia grave:** letargia ou inconsciência, incapacidade de beber, pulso radial fraco ou ausente, anúria, hipotensão [Limit.]
- **Sinais de abdome agudo:** distensão, rigidez, descompressão brusca dolorosa, íleo, dor localizada em quadrante inferior → TC [Abund.]
- **Febre alta persistente ou aspecto toxêmico** → hemocultura; **febre + cefaleia/mialgia** → tifoide ou *Listeria* (rigidez de nuca, gestante) [Abund.]
- **Sangue visível** nas fezes, sobretudo com plaquetopenia (risco de SHU) ou reação leucemoide (*C. difficile*) [Abund.]
- **Hospedeiro de risco:** ≥70 anos, cardiopatia, imunossupressão, DII, gestação, neutropenia (<500 células/µL com febre e dor: enterocolite neutropênica → TC) [Abund.]
- **Falha terapêutica:** piora em 24–48 h ou ausência de resposta em 48 h ao antibiótico; diarreia persistente (>14 dias) → ampliar a investigação [Limit.][Abund.]
- **Sem diurese após reposição**, íleo, bradicardia, confusão, convulsão ou sede intensa com inquietação (hipernatremia) → eletrólitos e glicose [Limit.]

4.6 Complicações

Complicação	Agente associado	Comentário
Hipovolemia e distúrbios eletrolíticos	Principalmente cólera	Complicação sistêmica mais importante; na Shigella a desidratação grave é incomum
Bacteremia	Shigella, Salmonella não tifoide, C. fetus	Preocupação especial em HIV; em <5% das gastroenterites por Salmonella; endocardite, aneurisma micótico, abscessos, osteomielite
Síndrome hemolítico-urêmica	Shigella, STEC	Toxinas Shiga lesam o endotélio
Síndrome de Guillain-Barré	C. jejuni	—
Artrite reativa	Campylobacter, Salmonella, Shigella flexneri	—
Shigella: sepse, convulsões, prolapso retal, megacólon tóxico, encefalopatia	Shigella	Mortalidade da disenteria epidêmica: 10–20% sem tratamento e 5% com tratamento

Fonte: [Limit.] Tabelas 2 e 3 e texto; [Salm.].

4.7 Cenário e população

Cenário / população	O que muda
Maioria dos adultos	Não procura atendimento; sintomas leves ou transitórios [Abund.]
Urgência / internação	Indicações: febre persistente, diarreia sanguinolenta, dor intensa, depleção de volume, DII, imunossupressão complexa ou doença cardiovascular significativa [Abund.]
Ambulatório	Suporte com SRO e dieta; testar fezes só se critérios (seção 5)
Idoso (≥70 anos)	Hospedeiro de risco: testar fezes e considerar antibiótico; >50 anos com aterosclerose: risco de infecção endovascular se houver bacteremia por Salmonella [Abund.][Salm.]
Gestante	Risco de listeriose ~20× após carnes/laticínios contaminados; Salmonella: indicações de tratamento iguais; possível transmissão transplacentária e perda fetal na doença disseminada [Abund.][Salm.]
Imunossuprimido	Mais parasitas e CMV (CMV: biópsia por endoscopia se CD4 <50 ou transplante); tratar salmonelose por ≥14 dias [Abund.][Salm.]
HSH	Shigella, Giardia, E. histolytica; considerar proctite (clamídia, gonorreia, sífilis, herpes) — anuscopia e testes [Abund.]

5. Diagnóstico

Raciocínio em dois níveis. (1) *Sindrômico:* é diarreia aguda? aquosa ou inflamatória (disenteria)? qual o grau de hipovolemia? há gravidade ou risco do hospedeiro? (2) *Etiológico:* só vale perseguir o agente quando o resultado muda a conduta ou tem impacto de saúde pública — “o valor do exame de fezes é maior quando o resultado tem impacto clínico ou de saúde pública” [Abund.]. Em cenários de recursos limitados o diagnóstico microbiológico não é feito na maioria dos casos e não é necessário ao manejo [Limit.].

5.1 Critérios operacionais e a lógica dos pontos de corte

Critério	Lógica
≥3 evacuações líquidas em 24 h; ≤14 dias = aguda	Acima de 14 dias a probabilidade de causa não infecciosa e de parasitas aumenta [Abund.]
Febre ≥38,5 °C; ≥6 evacuações/24 h; dor intensa; hipovolemia	Marcadores de maior carga bacteriana/invasão; nessas condições o benefício do antibiótico supera o baixo risco de complicação por STEC [Abund.]
Idade ≥70 anos, cardiopatia, imunossupressão, DII, gestação	Hospedeiros em que complicações (desidratação, bacteremia, endovascular) são mais prováveis ou mais graves [Abund.]
Sintomas >1 semana	Probabilidade de parasitas e de causa não infecciosa sobe; testar fezes [Abund.]
Antibiótico/internação ≤3 meses	Perfil de *C. difficile* [Abund.]
Internado há ≥72 h	Coprocultura de rotina tem pouco valor; testar *C. difficile* [Abund.]

5.2 Exames em ordem hierarquizada

Disponibilidade no SUS e sensibilidade/especificidade dos testes: não informado na fonte (a fonte [Salm.] afirma que a sensibilidade e a especificidade de uma ou várias coproculturas para salmonelose são desconhecidas).

Nível	Exame	O que responde / quando pedir	Limitações e interpretação
1. Beira-leito (todos)	Avaliação da volemia e do tipo de diarreia	Define se há hipovolemia e se é aquosa ou inflamatória; orienta SRO × IV e quem testa fezes	Sinais podem estar ausentes na hipovolemia precoce
2. Triagem (só se depleção importante, íleo, bradicardia, confusão, convulsão)	Painel metabólico (K^+, creatinina, Na^+, glicose)	Hipocalemia e disfunção renal; hipernatremia	Não rotineiro em diarreia aquosa não complicada
	Hemograma	Gravidade/complicações: plaquetopenia → SHU; reação leucemoide → *C. difficile*	Não distingue etiologia bacteriana de outras
	Hemocultura	Febre alta ou aspecto sistêmico; salmonelose com internação, enxerto endovascular/aterosclerose, <12 meses ou >50 anos	—
3. Fezes — bactérias (se gravidade, inflamatória, risco, >1 semana, saúde pública)	Coprocultura	Salmonella, Campylobacter e Shigella (positiva em sintoma agudo = verdadeiro positivo). Amostra diarreica, semeada rapidamente; swab retal se não houver fezes (menor sensibilidade em adultos)	Bactérias são excretadas continuamente — cultura negativa raramente é falso-negativa; repetir raramente é útil. Aeromonas e a maioria das Yersinia, Vibrio, Listeria e Campylobacter exigem aviso ao laboratório/meio seletivo. E. coli O157 em ágar sorbitol-MacConkey
	Painel molecular multiplex (bactérias, vírus, parasitas)	Mesmas indicações da cultura; reduz tempo, custo e prescrição de antibiótico em alguns estudos	Detecta material genético (não prova organismo viável); coinfecções são comuns; **positivo para bactéria exige cultura confirmatória** (antibiograma e saúde pública); utilidade clínica incerta para Salmonella
4. Dirigido por exposição	Toxina Shiga (imunoensaio/molecular) + leucócitos ou lactoferrina fecais	Diarreia com sangue visível: STEC (não tratar com antibiótico) e ameba (sangue sem leucócitos)	Cultura em sorbitol-MacConkey não detecta outras cepas produtoras de toxina Shiga; confirmar com o laboratório como o teste é feito
	C. difficile	Antibiótico ou internação nos últimos 3 meses; DII	Espessamento parietal do cólon na TC é característico, mas inespecífico
	Parasitológico (3 amostras em dias consecutivos, ≥24 h) ou antígeno/molecular	Persistente (>7 dias no algoritmo), HIV avançado (CD4 <200), HSH, surto hídrico, sangue sem leucócitos	Parasitas são excretados de modo intermitente; *Cryptosporidium* exige coloração especial (ácido-resistente modificada ou tricrômico); não custo-efetivo na diarreia aguda de rotina
5. Cenário de recursos limitados	Microscopia de fezes frescas	>20 leucócitos/campo = invasão bacteriana; trofozoítos com hemácias = disenteria amebiana (tratar ameba); cólera: microscopia em campo escuro (“estrelas cadentes”) ou teste rápido em fita	Cistos/trofozoítos sem hemácias em fezes com sangue não provam ameba (portadores assintomáticos são comuns)

Nível	Exame	O que responde / quando pedir	Limitações e interpretação
6. Imagem/endoscopia (exceção)	TC de abdome	Sinais peritoneais, íleo ou dor bem localizada em quadrante inferior: perfuração, abscesso, colite fulminante, megacólon tóxico, obstrução; risco de isquemia colônica; neutropenia (<500) com febre e dor	Raramente muda a conduta na diarreia aguda de rotina
	Endoscopia com biópsia	DII se a diarreia não resolve; CMV (HIV com CD4 <50, transplantados)	—

Por cenário — **urgência/internação:** avaliação de volemia e eletrólitos, hemograma, hemocultura se febril ou toxêmico, coprocultura/painel molecular, TC se abdome agudo. **Ambulatório:** clínica; fezes apenas se critérios acima. Fontes: [Abund.], [Limit.], [Salm.].

Nota de leitura crítica:

O painel molecular é conveniente, mas “achar” um micro-organismo não equivale a diagnosticar a causa. Em 2023, 78% das infecções bacterianas notificadas ao FoodNet foram diagnosticadas por testes independentes de cultura, o que aumenta a importância de pedir a cultura confirmatória [Abund.]. A evidência de que o painel reduz custo e antibiótico é descrita como “alguma evidência” — provavelmente observacional.



Figura 3. *Entamoeba histolytica*: trofozoíto com hemácias fagocitadas, corado por tricrômico. A presença de hemácias dentro do trofozoíto é o achado que sustenta amebíase invasiva em fezes com sangue. *Extraída de [Limit.] (Picture 2), que a reproduz do CDC (DPDx: Amebiasis); texto original em inglês.*

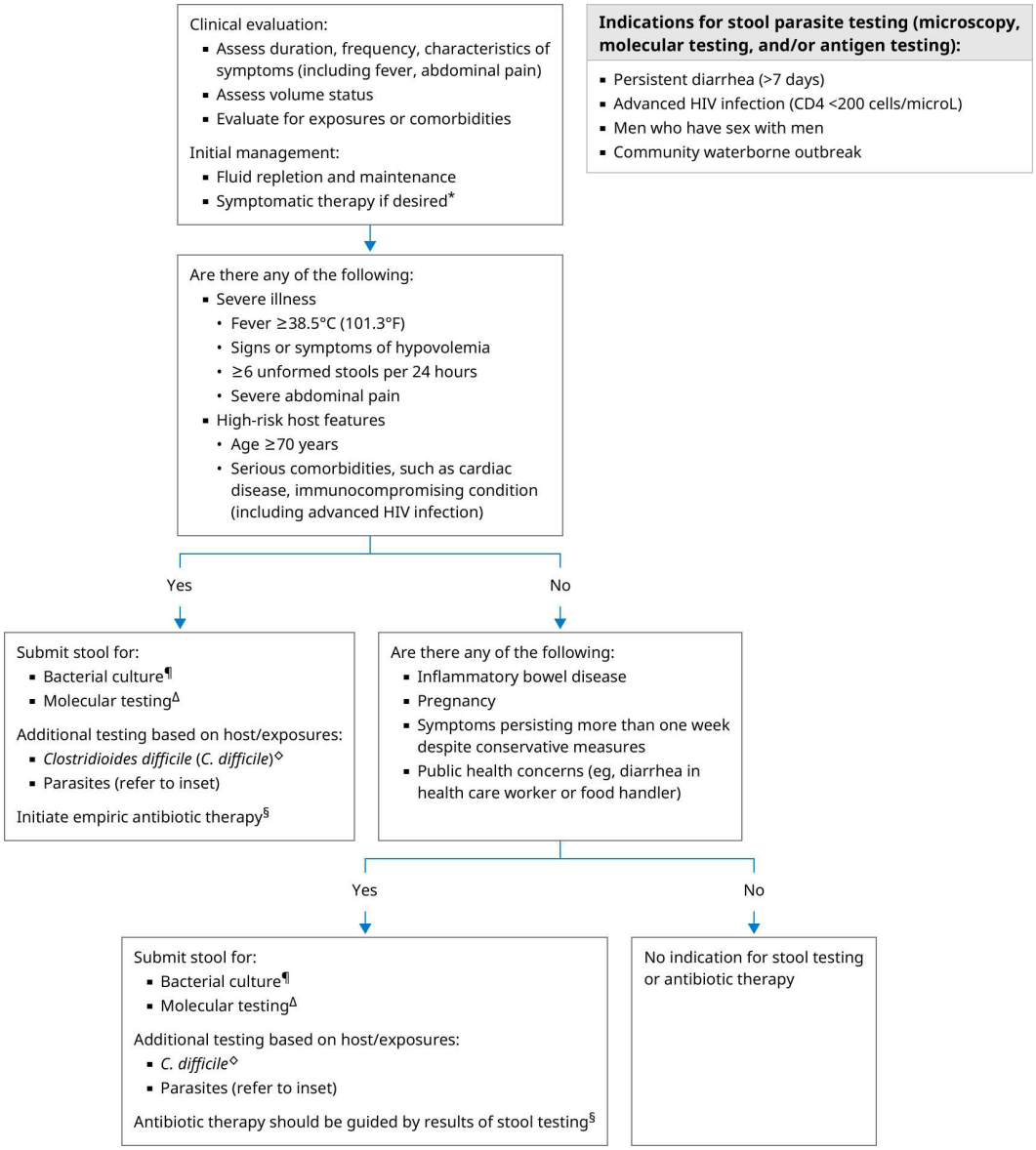


Figura 4. Algoritmo de abordagem da diarreia aguda não sanguinolenta em adultos em cenário de recursos abundantes: avaliar volemia e hidratar; presença de gravidade ou risco → coprocultura + teste molecular (± *C. difficile*, parasitas) e antibiótico empírico; sem gravidade, mas com DII, gestação, sintomas >1 semana ou preocupação de saúde pública → testar e guiar o antibiótico pelo resultado; nenhum desses → sem exame nem antibiótico. Quadro à direita: indicações de pesquisa de parasitas (persistente >7 dias, HIV com CD4 <200, HSH, surto hídrico). Rodapés originais: loperamida e bismuto são eficazes (loperamida um pouco mais); coprocultura de rotina identifica Salmonella, Campylobacter e Shigella; positivo em painel molecular requer cultura confirmatória; *C. difficile* se antibiótico/internação ≤3 meses. *Extraída de [Abund.] (Algorithm 1); texto original da figura em inglês.*

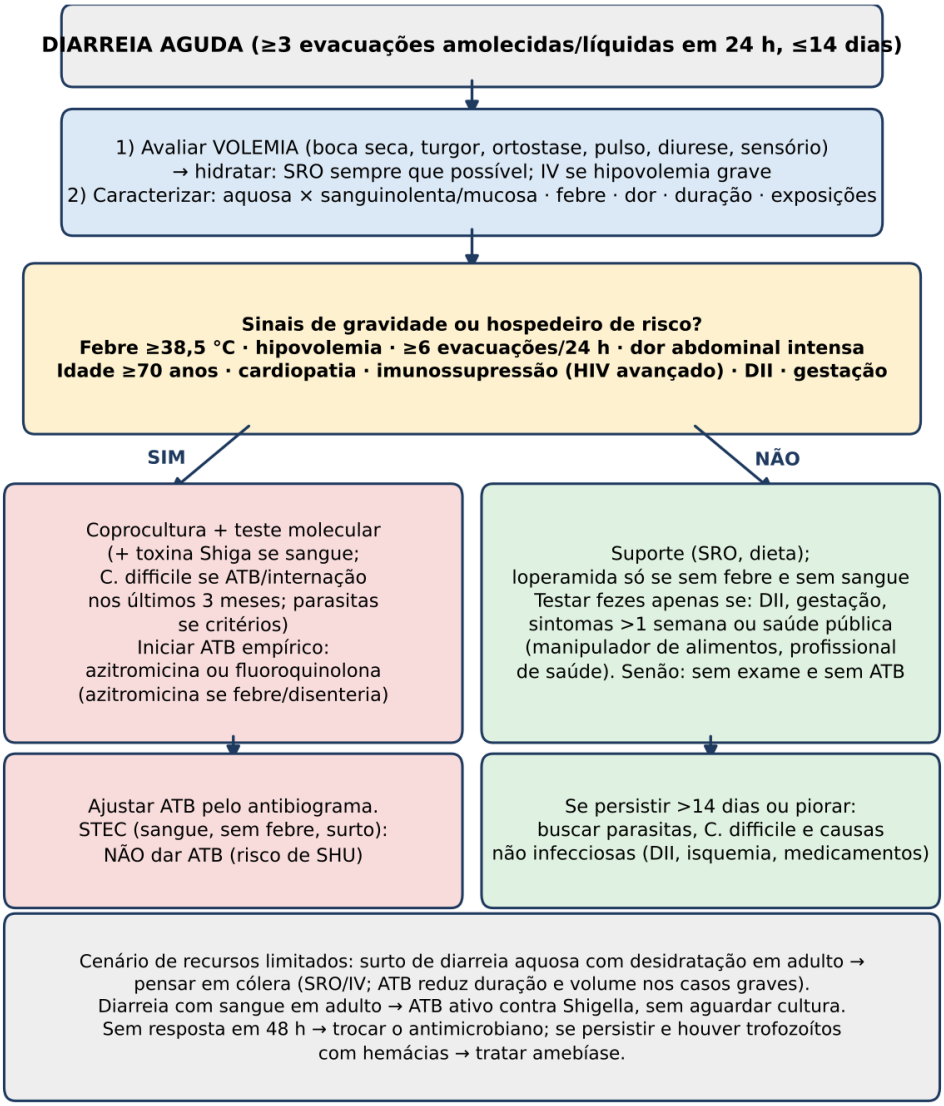


Figura 5. Algoritmo integrado, em português, que combina as decisões das quatro fontes (volemia → gravidade/risco → exames e antibiótico). *Elaborado a partir de [Abund.] (Algorithm 1) e [Limit.] — não consta na fonte nesse formato.*

5.3 Diagnósticos diferenciais (formato de tutoria)

Elaborado a partir de [Abund.], [Limit.] e [Salm.] — a fonte não organiza o diferencial nesse formato. "Esperado e ausente" indica o que faria duvidar da hipótese.

Hipótese	Achados a favor	Achados contra	Esperado se fosse correta, mas ausente	Achado que discrimina
Gastroenterite viral (norovírus, rotavírus)	Aquosa, vômitos, surto em restaurante/creche/cruzeiro, incubação 24–48 h; autolimitada	Sangue, febre alta, leucócitos fecais	Resolução em poucos dias; >14 dias contraria	Ausência de sinais inflamatórios; coprocultura negativa (positiva em só 1,5–5,6%)
Toxina pré-formada (S. aureus, B. cereus) / C. perfringens	Vômito ≤6 h após a refeição; 8–16 h para C. perfringens	Febre, sangue, evolução >1–2 dias	Outros comensais com sintomas após a mesma refeição	Latência curta entre o alimento e o início
Salmonella não tifoide	Febre, cólica, náusea/vômito; 8–72 h; aves, ovos, répteis; febre cede em 48–72 h	Sangue franco (mais Shigella/EHEC); doença >10 dias	Febre; fonte alimentar ou animal	Coprocultura (clinicamente indistinguível de outras causas)
Shigelose	Pequenas evacuações com sangue ± muco, tenesmo, febre; creche, HSH, aglomeração	Grande volume aquoso sem sangue	Leucócitos fecais; resposta a antibiótico em 48 h	Coprocultura; epidemia com baixa dose infectante (10–100)
STEC (E. coli O157:H7)	Sangue visível, sem febre, carne moída/surto	Febre alta	Sangue sem febre; cultura em sorbitol-Mac Conkey/toxina Shiga	**Toxina Shiga positiva**; implicação: não dar antibiótico

Hipótese	Achados a favor	Achados contra	Esperado se fosse correta, mas ausente	Achado que discrimina
C. difficile	Antibiótico/internação ≤3 meses, IBP, quimioterapia; leucocitose (reação leucemoide); espessamento colônico	Nenhuma exposição de risco	Teste positivo; febre e dor	Teste para *C. difficile*
Cólera / ETEC	Aquosa profusa, “água de arroz”, vômitos, sem febre, hipovolemia grave; surto/viagem	Sangue; febre	Desidratação rápida	Campo escuro/teste rápido; contexto epidêmico
Amebíase (E. histolytica)	Sangue sem leucócitos fecais; incubação 1–3 semanas; viagem, HSH	Início em horas após uma refeição (a incubação é de 1–3 semanas)	Persistência; trofozoítos com hemácias	**Trofozoítos com hemácias** à microscopia
Giardíase / Cryptosporidium	Persistente (>7–14 dias), creche, piscina, água, HIV	Quadro agudo curto com sangue	Parasitológico ou antígeno positivo	Parasitologia ×3 ou antígeno/molecular; coloração especial para *Cryptosporidium*
Causas não infecciosas (DII, colite isquêmica)	Dor + sangue; fatores de risco vasculares; recorrência/persistência	Exposição alimentar clara; resolução rápida	Cultura negativa e piora ou cronificação	TC e/ou endoscopia

5.4 Quadro de raciocínio comparativo

Elaborado a partir de [Limit.] (Tabela 2 e texto), [Abund.] e [Salm.].

Linha	Cólera / secretora	Shigelose	STEC	Salmonella não tifoide
Condições facilitadoras	Saneamento precário, água contaminada, áreas endêmicas/epidêmicas	Aglomeração, campos de refugiados, creche, HSH; dose infectante 10–100	Carne moída, leite/suco sem pasteurização, surtos; creche, asilos	Aves, ovos, répteis; extremos de idade; HIV; transplante; aterosclerose
Fisiopatologia resumida	Enterotoxina → secreção de água; cotransporte preservado	Invasão e destruição da mucosa do cólon	Toxina Shiga → lesão endotelial → SHU	Invasão da mucosa; dose ingerida correlaciona com gravidade
Instalação	Súbita; vômitos e cólica	1–3 dias	1–8 dias	8–72 h
Sítio	Intestino delgado	Cólon	Cólon	Delgado e cólon
Gravidade	Hipovolemia grave/choque; letalidade 40% sem tratamento	Letalidade 10–20% sem tratamento; sepse, convulsões, SHU	SHU	<5% bacteremia; mortalidade 0,5–1% em surtos (provável superestimativa)
Cronologia	Dias; rápida desidratação	Melhora com antibiótico em 48 h	Dias	Febre 48–72 h; diarreia 4–10 d; excreção mediana 5 sem
Exame físico	Desidratação franca, sem febre	Febre, dor retal/tenesmo	Sem febre; dor	Febre, cólica
Laboratório	Campo escuro / fita	Leucócitos fecais; cultura	Toxina Shiga; plaquetopenia	Coprocultura; hemocultura em risco
Imagem	Não informado na fonte	Não informado na fonte	Não informado na fonte	Não informado na fonte

5.5 Armadilhas clínicas

- **“Tem sangue, então dou antibiótico.”** Sangue visível sugere Shigella/STEC; na salmonelose muitos têm só sangue oculto. Em STEC suspeito e estável, **retenha** o antibiótico até o teste — a associação com SHU é descrita sobretudo com beta-lactâmicos [Abund.][Salm.].
- **“Sem leucócitos nas fezes, não é infecção invasiva.”** A ameba destrói leucócitos; sangue sem leucócitos sugere amebíase [Abund.].
- **“Vi trofozoíto, é ameba.”** Sem hemácias dentro, pode ser colonização assintomática [Limit.].
- **“Diarreia após internação = pedir coprocultura.”** Após ≥72 h de internação, o mais útil é testar *C. difficile* [Abund.].
- **“Loperamida resolve.”** Em disenteria sem antibiótico pode prolongar a doença; mascara perdas de volume [Abund.].
- **“Bebida esportiva é SRO.”** Não: eletrólitos e osmolaridade diferem (ver tabela SRO × bebidas, seção 6) [Abund.][TRO].

- **“Cultura de controle negativa = curou.”** Uma única cultura negativa não garante que cessou a eliminação; controle de rotina não é indicado em imunocompetentes [Salm.].
- **“Diarreia + febre + cefaleia = só gastroenterite.”** Pensar em tifoide (viajante) e *Listeria* (gestante, rigidez de nuca) [Abund.].
- **DII e isquemia colônica** imitam disenteria infecciosa; se não há patógeno e a diarreia piora ou cronifica, investigar causa não infecciosa [Abund.].

6. Tratamento

Princípio: o tratamento mais importante é a reidratação, preferencialmente oral, com água, sal e açúcar; antibiótico só em situações selecionadas [Abund.][Limit.]. Doses e condutas abaixo vêm das fontes; o que foi complementado por outras fontes está marcado com [Externo: ...].

6.1 Conduta inicial: avaliar volemia e repor

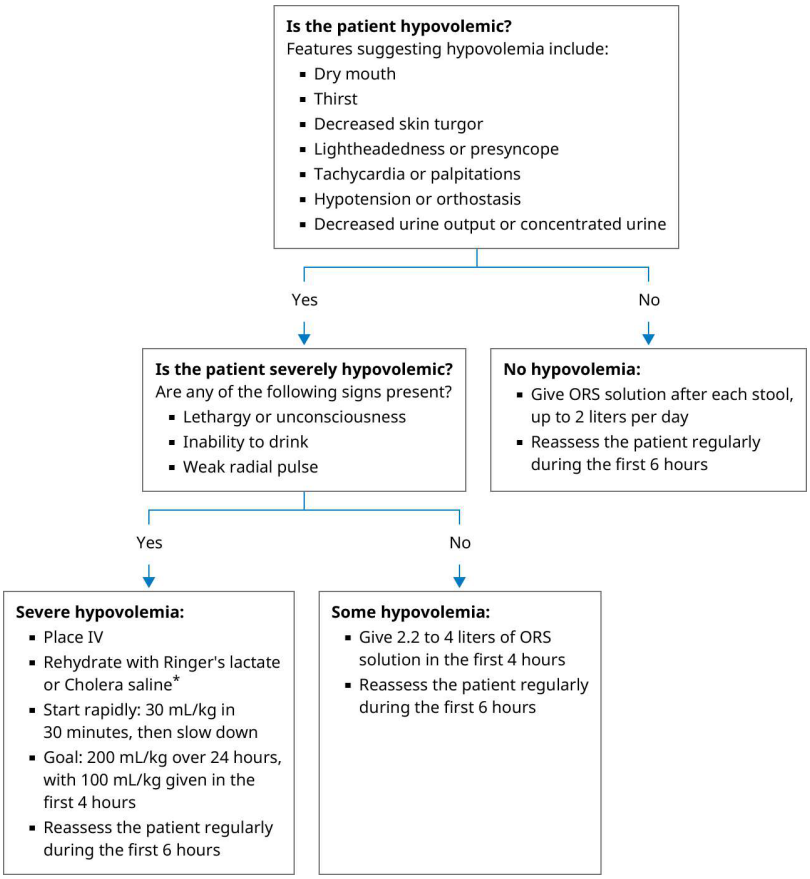


Figura 6. Manejo de fluidos no adulto com diarreia aguda. Sem hipovolemia: SRO após cada evacuação (até 2 L/dia) e reavaliação nas primeiras 6 h. Alguma hipovolemia: 2,2 a 4 L de SRO nas primeiras 4 h. Hipovolemia grave (letargia ou inconsciência, incapacidade de beber ou pulso radial fraco): acesso IV, Ringer lactato ou solução de cólera, 30 mL/kg em 30 minutos e depois mais lentamente, com meta de 200 mL/kg em 24 h (100 mL/kg nas primeiras 4 h); se não houver, usar soro fisiológico, de preferência com potássio. *Extraída de [Limit.] (Algorithm 1; cortesia de LaRocque e Pietroni); texto original em inglês.*

Estado de volume	Conduta (adulto)	Fonte
Sem hipovolemia	SRO após cada evacuação, até 2 L/dia; manter alimentação; reavaliar nas primeiras 6 h	[Limit.]
Alguma hipovolemia (leve–moderada)	SRO 2,2–4 L nas primeiras 4 h (ou 50–100 mL/kg em 3–4 h, inclusive em adolescentes e adultos se bem tolerada); repor perdas contínuas (ex.: 1 mL de SRO por g de fezes; em crianças, 10 mL/kg por evacuação líquida e 2 mL/kg por vômito); reavaliar de hora em hora	[Limit.][TRO]
Hipovolemia grave	IV: Ringer lactato (± dextrose 5%) ou solução de cólera (Dhaka); 30 mL/kg em 30 min, depois reduzir; meta 200 mL/kg em 24 h; trocar para SRO quando estável e consciente. SF 0,9% é menos preferível (sem potássio e sem base). Cuidado com cardiopatia (infusão rápida)	[Limit.][TRO][Abund.]
Suspeita de STEC (sangue, sem febre)	Alguns especialistas preferem hidratação IV	[Abund.]

Qual solução? SRO padrão da OMS ou comercial, com osmolaridade 200–310 mOsm/L, sódio e glicose equimolares, glicose <20 g/L, sódio 60–90 mEq/L, potássio 15–25 mEq/L, citrato 8–12 mmol/L e cloreto 50–80 mEq/L [TRO]. Em paciente não hipovolêmico e saudável, caldos, sucos diluídos, refrigerantes e biscoitos salgados podem bastar; a SRO é preferida quando há doença mais grave, tanto para repor quanto para manter volume [Abund.]. Em casa, usar produto comercial pronto — soluções caseiras com açúcar e sal levam a grandes erros [TRO].

Solução	Carboidrato (g/L)	Na^+ (mEq/L)	K^+ (mEq/L)	Base (mEq/L)	Osmolaridade (mOsm/kg)
SRO CeraLyte	40	70	20	10	235
SRO Enfalyte	30	50	25	30	200
SRO Pedialyte	25	45	20	30	250
SRO OMS (2002)	13,5	75	20	30	245
Suco de maçã*	100–150	3	20	0	700
Caldo de galinha*	0	250	5	0	450
Refrigerante de cola*	100–150	2	0,1	13	550
Gatorade*	61	20	3	3	330
Ginger ale*	90	3,5	0,1	3,6	565
Chá*	0	0	0	0	5

* Bebidas comuns, **não apropriadas** para reidratação. Fonte: [Abund.] Tabela 4 e [TRO] Tabela 1. SRO hipo-osmolar da OMS por litro de água limpa: cloreto de sódio 2,6 g, citrato de sódio 2,9 g, cloreto de potássio 1,5 g, glicose 13,5 g [Limit.] Tabela 5.

Por que isso importa clinicamente:

Quando a SRO falha, a causa costuma ser clara e reconhecível: volume de fezes persistentemente excessivo, vômitos graves com ingestão insuficiente, alteração do sensório com risco de aspiração, íleo ou má absorção intrínseca. Nesses casos, passar para IV; ao estabilizar, retornar à via oral [TRO]. Dar a SRO em pequenos volumes frequentes (em crianças, 5 mL a cada 1–2 minutos permite 150–300 mL/h) reduz a chance de vômito.

Antiemético auxiliar

Em vômitos significativos, dar **ondansetrona** e iniciar a SRO cerca de 15 minutos depois, em pequenos volumes; a evidência na fonte é pediátrica (reduz necessidade de IV e internação) [TRO]. Posologia em adultos: [Externo: WikEM, consulta 2026] 4–8 mg a cada 4 h, máximo 24 mg/dia. Extrapolação do achado pediátrico para o adulto: a fonte principal de adultos não discute o antiemético.

Alta e orientações

Critérios de alta de ambiente supervisionado para manejo domiciliar [TRO]: volume razoável de SRO administrado para o grau de desidratação (sinais vitais, sensório e diurese normalizados, sem vômitos incoercíveis nem recusa); nenhuma suspeita de outra doença que complique; sem barreiras sociais ou logísticas para retorno; cuidadores/paciente orientados sobre SRO em casa e sinais de retorno.

Dieta

- Manter nutrição (favorece a renovação dos enterócitos); jejum curto de líquidos é inócuo se houver anorexia ou vômitos. Na diarreia aquosa: amidos e cereais cozidos com sal (batata, macarrão, arroz, trigo, aveia), biscoitos, banana, sopas, legumes cozidos; evitar alimentos gordurosos até a função intestinal normalizar [Abund.][Limit.].
- Evitar lácteos (exceto iogurte) temporariamente: má absorção secundária de lactose pode durar semanas a meses [Abund.].
- **Probióticos:** uso em adultos com gastroenterite infecciosa é não comprovado [Abund.].

6.2 Antibiótico: quando e qual

Situação	Recomendação	Graduação (UpToDate)
Diarreia aguda aquosa, sem gravidade, sem viagem [Abund.]	**Não** dar antibiótico empírico: benefício (redução de sintomas) não supera toxicidade, resistência e risco de *C. difficile*	Grade 1B
Sangue visível em surto, estável, sem febre — suspeita de STEC [Abund.]	**Reter** antibiótico até teste afastar STEC; antibiótico não reduz sintomas ou complicações e se associa a SHU (sobretudo beta-lactâmicos)	Graduação não informada na fonte

Situação	Recomendação	Graduação (UpToDate)
Gravidade (febre ≥38,5 °C, hipovolemia, ≥6 evacuações/24 h, dor intensa), características inflamatórias (sangue, fezes mucoides de pequeno volume, febre) ou hospedeiro de risco (≥70 anos, cardiopatia, imunossupressão, DII, gestação) [Abund.]	**Sugerimos** antibiótico empírico: azitromicina ou fluoroquinolona (azitromicina se febre/disenteria ou risco de resistência a quinolona, ex.: viagem ao Sudeste Asiático, surtos com resistência)	Grade 2C
Recursos limitados: diarreia aquosa [Limit.]	Não dar antibiótico de rotina; exceção: cólera grave em surto (reduz duração e volume de perdas)	Grade 2B
Recursos limitados: diarreia com sangue [Limit.]	Antibiótico imediato eficaz contra Shigella, guiado por antibiograma local; se sem dados, ciprofloxacino ou azitromicina; trocar se não responder em 48 h; se persistir, tratar amebíase	Grade 2B
Salmonelose, imunocompetente 12 meses–50 anos, leve a moderada [Salm.]	**Não** tratar de rotina	Grade 2B
Salmonelose grave (>9–10 evacuações/dia, febre alta/persistente, internação) ou alto risco de doença invasiva (<12 meses, >50 anos com doença vascular, HIV mal controlado, imunossuprimidos, aterosclerose, prótese valvar/articular) [Salm.]	Tratar com antibiótico	Grade 2C

Duração. Salmonella — grave em imunocompetente sem bacteremia: 3–7 dias; tratado por idade/doença vascular/prótese (sem sintomas graves): 3–14 dias; imunocomprometido: ≥14 dias (semanas a meses, em alguns casos); HIV com CD4 <200: 2–6 semanas; recidiva/excreção persistente em paciente de alto risco: em geral 4–6 semanas [Salm.]. Shigella: 3 dias (levofloxacino, ciprofloxacino, azitromicina) ou 5 dias (cefixima, ceftriaxona, SMX-TMP, ampicilina); *S. dysenteriae* tipo 1 ou HIV: 5–7 dias; bacteremia: 14 dias [Limit.]. Amebíase: metronidazol 500–750 mg VO 3×/dia por 7–10 dias, seguido de agente intraluminal [Limit.].

Opção empírica	Eficácia / espectro	Efeitos adversos e cuidados	Custo; SUS
Azitromicina (VO)	Ativa contra a maioria das causas infecciosas; preferida em febre/disenteria e risco de resistência a quinolonas; dose única 1 g ou 500 mg/dia × 3 dias	Náusea maior em dose única (dividir em duas doses); teste de sensibilidade de Salmonella à azitromicina não padronizado [Salm.]	Não informado na fonte
Fluoroquinolona (cipro/levo)	Ativa contra a maioria das causas; alta concentração tecidual e intracelular	Tendinite, anormalidades da aorta, efeitos neurológicos, disfunção metabólica [Salm.]; náusea maior em dose única; resistência regional	Não informado na fonte
Ceftriaxona (IV/IM)	Atrativa quando parenteral é viável; ativa em quase todos os patógenos clinicamente significativos, **exceto Campylobacter**	Beta-lactâmicos: associação com SHU em STEC	Não informado na fonte
Carbapenêmico (IV)	Empírico em shigelose grave com risco de resistência (HSH, viajantes, HIV, situação de rua) até antibiograma	Dose não informada na fonte	Não informado na fonte

Situações especiais [Abund.]: diarreia grave com antibiótico nos 3 meses anteriores e alta suspeita de *C. difficile* → tratamento empírico para ele é razoável; gestante com diarreia e febre/doença sistêmica e possível exposição a *Listeria* → antibiótico com atividade contra esse agente; diarreia aquosa profusa com exposição à cólera → cobrir *V. cholerae*; HSH com proctite → testes e tratamento empírico para clamídia e gonorreia podem ser necessários.

Cólera: antibiótico oral (adulto)	Dose [Limit.] Tabela 7	Comentário
Doxiciclina	300 mg, dose única	Resistência a tetraciclinas é comum; empírica só em surto com cepa suscetível; evitar em gestantes e <8 anos se houver alternativa (dose única provavelmente segura; CDC/GTFCC aceitam em ausência de resistência)
Tetraciclina	500 mg 4×/dia por 3 dias	Idem
Azitromicina	1 g, dose única	Raros relatos de resistência a macrolídeos
Ciprofloxacino	500 mg 2×/dia por 3 dias	Susceptibilidade reduzida a quinolonas na Ásia e África; reduzir dose se ClCr <30 mL/min

Shigelose: antibiótico (adulto)	Dose [Limit.] Tabela 8	Duração
Levofloxacino	500 mg VO 1×/dia	3 dias
Ciprofloxacino	500 mg VO 2×/dia ou 750 mg VO 1×/dia	3 dias

Shigelose: antibiótico (adulto)	Dose [Limit.] Tabela 8	Duração
Azitromicina	500 mg VO 1×/dia	3 dias
Cefixima (falhas relatadas; seguimento clínico)	200 mg VO 2×/dia	5 dias
Ceftriaxona	1–2 g IV 1×/dia	5 dias
SMX-TMP	160/800 mg VO 2×/dia	5 dias
Ampicilina	500 mg VO a cada 6 h	5 dias

Escolher pelo antibiograma; se empírico, pesar demografia e resistência local. *S. dysenteriae* tipo 1 ou HIV: 5–7 dias; bacteremia: 14 dias.

Nota de leitura crítica:

Evidência por trás das recomendações antibióticas: (1) O benefício da antibioticoterapia na salmonelose leve vem de uma meta-análise de 12 ensaios (767 pessoas saudáveis) sem ganho em duração da doença, diarreia ou febre; esses ensaios geralmente excluíram doença grave. (2) Em estudo com mais de 500 pacientes, o norfloxacino prolongou o tempo mediano até a negativação da cultura (50 versus 23 dias com placebo). (3) O benefício em doença grave vem de ensaios que sugerem melhora clínica 1–2 dias mais rápida; o texto admite que não foi demonstrado em grandes ensaios randomizados. (4) A associação STEC–SHU–antibiótico é observacional. (5) Os ensaios de tratamento empírico da diarreia grave comunitária envolveram sobretudo adultos saudáveis; a extrapolação para idosos e imunossuprimidos é inferência, não dado do estudo.

6.3 Tratamento sintomático

Agente	Dose	Quando usar	Eficácia / limitações	Efeitos adversos
Loperamida	4 mg inicial, depois 2 mg após cada evacuação não formada; <2 dias; máx. 16 mg/dia [Abund.]	Diarreia sem sangue e sem febre (ou febre baixa); evitar em disenteria, a menos que haja antibiótico (Grade 2C); em geral evitada se *C. difficile* suspeito	Menos evacuações líquidas/menor tempo (cerca de 1 dia) vs placebo; com antibiótico acelera a resolução; **pode mascarar perda de volume** — hidratar agressivamente	[Externo: PDR] constipação, náusea, dor; íleo e megacólon tóxico; arritmia (torsades) com doses acima das recomendadas; contraindicações: <2 anos, associação com cisaprida, cetoconazol, itraconazol, fluconazol, dronedarona
Difenoxilato	5 mg (2 comprimidos) 4×/dia por <2 dias [Abund.]	Alternativa antimotilidade	Menos estudado	Efeitos opioides centrais ou colinérgicos
Subsalicilato de bismuto	30 mL ou 2 comprimidos a cada 30 min × 8 doses [Abund.]	Alternativa em febre/disenteria quando loperamida é evitada	Reduz evacuações não formadas vs placebo; menos eficaz que loperamida	Toxicidade por salicilato (aspirina, gestantes)
Racecadotril (inibidor de encefalinase)	[Externo: Fischbach et al., Front Med, 2016] 100 mg 3×/dia	Antissecretor; opção se disponível (não disponível nos EUA); disponibilidade no Brasil: não informado na fonte	Reduz débito e duração da diarreia; em alguns estudos melhora mais rápida e menos efeitos adversos que loperamida	[Externo: Fischbach et al.] menos distensão e menos constipação que loperamida; prurido; cautela em intolerância a carboidratos (contém sacarose)

6.4 Individualização

Grupo	Ajuste
Idade ≥70 anos / cardiopatia	Hospedeiro de risco → testar fezes e considerar antibiótico; hidratar com cautela (infusão rápida pode descompensar) [Abund.]
Gestação	Salmonelose: mesmas indicações; considerar rastreio materno-infantil perto do parto; Listeria em febre + sintomas gastrintestinais; bismuto: cautela (salicilato); cipro/doxiciclina: evitar em gestantes e <8 anos se houver alternativa [Salm.][Abund.][Limit.]
Imunossuprimido / HIV	Salmonelose: ≥14 dias (CD4 <200: 2–6 semanas); avaliar bacteremia e infecção extraintestinal; CMV e parasitas; consultar infectologia [Salm.][Abund.]
Função renal/hepática	Cipro na cólera: reduzir dose se ClCr <30 mL/min; demais ajustes: não informado na fonte
Crianças (não é o foco)	Azitromicina na salmonelose: 10 mg/kg no dia 1 (máx. 500 mg), depois 5 mg/kg (máx. 250 mg) por 4 dias; ceftriaxona 50 mg/kg (máx. 1 g) em doença grave [Salm.]
Contexto/acesso	Em recursos limitados o diagnóstico microbiológico é dispensável; guiar pelo tipo de diarreia (aquosa × sangue) e pela volemia; resistência é crescente — evitar antibiótico sem indicação [Limit.]

6.5 Internação, encaminhamento e UTI

- **Considerar internação:** persistência de febre, diarreia sanguinolenta, dor abdominal intensa, sinais de depleção de volume, DII, imunossupressão, doença cardiovascular significativa [Abund.].
- **IV imediato:** hipovolemia grave; falha de TRO (débito excessivo ou vômitos graves persistentes) [TRO][Limit.].
- **TC / cirurgia:** sinais peritoneais, íleo, dor localizada em quadrante inferior, suspeita de megacólon tóxico [Abund.].
- **Infectologia:** imunossuprimidos com salmonelose, recidivas e uso prolongado de antibiótico [Salm.].
- **Notificar a saúde pública** em surtos e em situações de manipuladores de alimentos, profissionais de saúde e creche [Abund.][Salm.].

6.6 Protocolo brasileiro do Ministério da Saúde (complemento externo)

[Externo: Ministério da Saúde, cartaz “Manejo do paciente com diarreia”, consultado em 2026] — Plano A (sem desidratação): mais líquidos que o habitual após cada evacuação (acima de 10 anos: o quanto aceitar), manter alimentação, retorno se piora ou sinais de perigo; zinco 20 mg/dia por 10–14 dias (>6 meses). Plano B (desidratação, sem sinais de gravidade): SRO na unidade de saúde, 50–100 mL/kg em 4–6 h, reavaliação; sonda nasogástrica se não hidratar; passa a Plano C se piorar. Plano C (desidratação grave): >5 anos, inclusive adultos — SF 0,9% 30 mL/kg em 30 min, depois Ringer lactato 70 mL/kg em 2 h 30 min; manutenção com SG 5% + SF 0,9% (4:1) e reposição (1:1); KCl 10%. Adulto com diarreia e sangue: ciprofloxacino 500 mg VO 12/12 h por 3 dias; se sangue/melena persistem após 48 h e bom estado geral, ceftriaxona 2 g IM 1×/dia por 2–5 dias; mau estado geral: encaminhar ao hospital.

Ponto	UpToDate ([Limit.]/[Abund.])	Ministério da Saúde [Externo]	Divergência
Reposição IV na hipovolemia grave	30 mL/kg em 30 min; meta 200 mL/kg em 24 h (100 mL/kg nas 4 primeiras horas); Ringer lactato ou solução de cólera	30 mL/kg SF 0,9% em 30 min + 70 mL/kg Ringer lactato em 2 h 30 min (>5 anos)	Sim: o MS fixa 100 mL/kg em ~3 h com SF 0,9% e depois Ringer; a fonte prefere Ringer lactato/cólera e aceita SF só se faltar
SRO na desidratação leve–moderada	2,2–4 L em 4 h (adulto)	50–100 mL/kg em 4–6 h	Compatíveis; janelas de tempo diferentes
Adulto com sangue nas fezes	Antibiótico imediato (azitromicina ou cipro; cipro 500 mg 12/12 h 3–5 d; azitro 500 mg/d 3 d)	Cipro 500 mg 12/12 h por 3 dias; ceftriaxona 2 g IM por 2–5 dias se persistir após 48 h	Ceftriaxona: UpToDate 1–2 g/dia por 5 dias; MS 2 g por 2–5 dias
Zinco	Crianças >6 meses em países com alta prevalência de deficiência	20 mg/dia por 10–14 dias (>6 meses)	Aplicação em adultos: não informado nas fontes

6.7 Prescrição-modelo comentada (pronto-socorro)

Elaborada a partir de [Abund.], [Limit.] e [TRO] — não consta na fonte nesse formato. Os valores das doses vêm das tabelas das fontes.

Cenário: homem de 36 anos, 3 dias de diarreia líquida com sangue e muco, 10 evacuações/dia, febre 38,8 °C, tenesmo, tontura ao levantar; sem uso recente de antibiótico; peso 70 kg. Exame: mucosas secas, PA 100×60 mmHg com queda ortostática, FC 108 bpm, abdome doloroso sem sinais peritoneais. **Detrator plausível:** “isso é só gastroenterite viral — dar loperamida”. Não: febre, sangue e muco = diarreia inflamatória com gravidade.

Item	Prescrição	Comentário
1. Dieta	Livre, fracionada; evitar frituras e lácteos (exceto iogurte)	Nutrição favorece renovação do enterócito; má absorção secundária de lactose
2. Hidratação	SRO (OMS hipo-osmolar) 2,2–4 L VO nas primeiras 4 h, em pequenos goles; depois SRO após cada evacuação (até 2 L/dia)	Alguma hipovolemia (sem letargia, consegue beber, pulso presente). Se não tolerar ou piorar → Ringer lactato IV 30 mL/kg (≈2,1 L) em 30 min e reavaliar
3. Antibiótico	**Azitromicina 500 mg VO 1×/dia por 3 dias**	Febre + disenteria: preferida (Tabela 5); alternativa: cipro 500 mg 12/12 h por 3–5 dias
4. Antimotilidade	**Não prescrever** loperamida	Disenteria com febre: só se houver antibiótico; aqui, evitar. Alternativa: subsalicilato de bismuto (se sem contraindicação)
5. Antiemético (se vômitos)	Ondansetrona 4–8 mg VO a cada 4–6 h (máx. 24 mg/dia) [Externo: WikEM]; SRO 15 min depois	Vômitos limitam SRO; evidência pediátrica extrapolada
6. Exames	Coprocultura + painel molecular (pedir cultura confirmatória se positivo); pesquisa de toxina Shiga; leucócitos/lactoferrina fecais; hemograma, creatinina, Na^+, K^+; hemocultura se febre persistente	Diarreia com sangue visível: STEC e ameba

Item	Prescrição	Comentário
7. Orientações	Retorno se febre persistente, sangue, vômitos incoercíveis, pouca urina, dor abdominal intensa; lavar as mãos	Reavaliar em 48 h (se sem resposta, trocar antibiótico; se trofozoítos com hemácias → tratar amebíase)

7. Tabela farmacológica consolidada

Inclui todos os fármacos citados nas quatro fontes, com as doses das fontes e complementos externos marcados. Classe/mecanismo: farmacologia geral [Externo: farmacologia de referência e bulas FDA/Anvisa] quando a fonte não descreve. Efeitos adversos e monitorização: apenas o que consta na fonte ou em fonte externa nomeada; o restante aparece como “não informado na fonte”.

Fármaco	Classe / mecanismo de ação	Posologia completa	Indicação específica nesta doença	Efeitos adversos principais	Monitorização necessária
SRO (OMS hipo-osmolar ou comercial)	Solução de reidratação oral; glicose + sódio equimolares aproveitam o cotransporte Na^+-glicose	Sem hipovolemia: após cada evacuação, até 2 L/dia. Alguma hipovolemia: 2,2–4 L nas primeiras 4 h (ou 50–100 mL/kg em 3–4 h, inclusive adultos) + reposição de perdas; depois manutenção. Fórmula/L: NaCl 2,6 g, citrato de Na 2,9 g, KCl 1,5 g, glicose 13,5 g (75 mEq/L Na^+, 75 mmol/L glicose, 245 mOsm/L) [Limit.][TRO]	Reposição e manutenção na diarreia de qualquer etiologia, exceto hipovolemia grave	Risco de erros graves com soluções caseiras [TRO]; outros: não informado na fonte	Reavaliar volemia nas primeiras 6 h (de hora em hora na reposição) [Limit.][TRO]
Ringer lactato (± dextrose 5%), **solução de cólera** (Dhaka), **soro fisiológico 0,9%**	Cristaloides IV; Ringer lactato e Dhaka contêm potássio e base; SF não	30 mL/kg em 30 min, depois mais lentamente; meta 200 mL/kg em 24 h (100 mL/kg nas 4 primeiras h). SF só se faltar os outros (idealmente com K^+). Crianças (TRO): bolus 20 mL/kg isotônico. [Externo: Ministério da Saúde] adultos >5 anos: SF 0,9% 30 mL/kg em 30 min + Ringer lactato 70 mL/kg em 2 h 30 min	Hipovolemia grave	Não informado na fonte; infusão rápida pode descompensar cardiopatas [Abund.]	Reavaliar nas primeiras 6 h; trocar para SRO ao estabilizar [Limit.]
Azitromicina	Macrolídeo; inibe a síntese proteica bacteriana [Externo: farmacologia de referência]	Aquosa: 500 mg VO 1×/dia por 3 dias, ou 1 g dose única (pode dividir em 2 doses para reduzir náusea); disenteria: 500 mg/dia por 3 dias [Abund.]. Salmonella: 1 g, depois 500 mg/dia por 5–7 dias [Salm.]. Shigella: 500 mg/dia por 3 dias. Cólera: 1 g dose única [Limit.]. Crianças: 10 mg/kg d1 (máx. 500 mg), depois 5 mg/kg (máx. 250 mg) por 4 dias [Salm.]	Preferida em febre/disenteria e se risco de resistência a quinolona; cólera; Shigella; Salmonella (alternativa)	Náusea (maior em dose única) [Abund.]; [Externo: bula FDA] prolongamento do intervalo QT	Sensibilidade da Salmonella não padronizada [Salm.]; ECG: não informado na fonte
Ciprofloxacino	Fluoroquinolona; inibe DNA-girase/topoisomerase IV [Externo: farmacologia de referência]	Aquosa: 500 mg 2×/dia por 3–5 dias ou 750 mg dose única; disenteria: 500 mg 2×/dia por 3–5 dias [Abund.]. Shigella: 500 mg 2×/dia ou 750 mg 1×/dia por 3 dias. Salmonella: 500 mg 2×/dia. Portador (seleção): 500 mg 2×/dia por 4 semanas. Cólera: 500 mg 2×/dia por 3 dias [Limit.][Salm.]. Se sintomas persistem 24 h após dose única: completar 3 dias. [Externo: Ministério da Saúde] adulto com sangue: 500 mg 12/12 h por 3 dias	Diarreia aguda grave/inflamatória/alto risco; Shigella; Salmonella grave; cólera (alternativa)	Tendinite, anormalidades da aorta, efeitos neurológicos, disfunção metabólica [Salm.]; náusea (dose única); evitar em gestantes e <8 anos se houver alternativa [Limit.]	Reduzir dose se ClCr <30 mL/min [Limit.]; resistência regional
Levofloxacino	Fluoroquinolona [Externo: farmacologia de referência]	500 mg VO 1×/dia por 3–5 dias ou 500 mg dose única [Abund.]; Shigella: 500 mg/dia por 3 dias; Salmonella: 500 mg/dia; portador: 500 mg/dia por 4 semanas	Mesmas do ciprofloxacino	Mesmos da classe	Idem
Ceftriaxona	Cefalosporina de 3ª geração [Externo: farmacologia de referência]	1–2 g IV/IM 1×/dia por 5 dias (empírico parenteral e Shigella) [Abund.][Limit.]; Salmonella: 1–2 g IV/dia; crianças: 50 mg/kg (máx. 1 g). [Externo: Ministério da Saúde] 2 g IM 1×/dia por 2–5 dias se sangue persiste após 48 h	Parenteral quando VO não é possível; sem atividade contra *Campylobacter*	Beta-lactâmicos associados a SHU em STEC [Abund.]; outros: não informado na fonte	Não informado na fonte

Fármaco	Classe / mecanismo de ação	Posologia completa	Indicação específica nesta doença	Efeitos adversos principais	Monitorização necessária
Cefotaxima	Cefalosporina de 3ª geração [Externo: farmacologia de referência]	2 g IV a cada 8 h [Salm.]	Salmonelose grave sem tolerância oral	Não informado na fonte	Não informado na fonte
Cefixima	Cefalosporina oral de 3ª geração [Externo: farmacologia de referência]	Salmonella: 400 mg 1×/dia ou 200 mg 2×/dia [Salm.]. Shigella: 200 mg 2×/dia por 5 dias [Limit.]	Salmonelose; shigelose (alternativa)	Falhas de tratamento relatadas [Limit.]	Seguimento clínico essencial [Limit.]
Sulfametoxazol-trimetoprima	Antagonista do folato [Externo: farmacologia de referência]	160/800 mg VO 2×/dia; Shigella: 5 dias [Limit.]; Salmonella: conforme situação; portador com isolado não suscetível a quinolona: 3 meses [Salm.]	Salmonelose e shigelose (se suscetível)	Não informado na fonte	Antibiograma
Amoxicilina	Penicilina [Externo: farmacologia de referência]	Salmonella: alta dose, 1 g VO 3×/dia [Salm.]; portador com isolado não suscetível a quinolona: 75–100 mg/kg/dia por 6 semanas	Salmonelose (alternativa); portador (seleção)	Não informado na fonte	Antibiograma
Ampicilina	Penicilina [Externo: farmacologia de referência]	500 mg VO a cada 6 h por 5 dias (Shigella) [Limit.]	Shigelose (se suscetível); alternativa pediátrica na salmonelose	Não informado na fonte	Antibiograma
Carbapenêmico	Beta-lactâmico de amplo espectro [Externo: farmacologia de referência]	Dose não informada na fonte [Abund.]	Shigelose grave com risco de resistência (HSH, viajantes, HIV, situação de rua), até antibiograma	Não informado na fonte	Antibiograma
Doxiciclina	Tetraciclina [Externo: farmacologia de referência]	Cólera: 300 mg dose única [Limit.]	Cólera em surto com cepa suscetível	Evitar em gestantes e <8 anos se houver alternativa (dose única provavelmente segura) [Limit.]	Resistência comum
Tetraciclina	Tetraciclina [Externo: farmacologia de referência]	500 mg 4×/dia por 3 dias [Limit.]	Cólera (alternativa)	Idem doxiciclina	Idem
Metronidazol	Nitroimidazólico; amebicida tecidual [Externo: farmacologia de referência]	500–750 mg VO 3×/dia por 7–10 dias, seguido de agente intraluminal [Limit.]	Disenteria amebiana (trofozoítos com hemácias ou falha de antibiótico)	Não informado na fonte	Não informado na fonte
Paromomicina (agente intraluminal)	Aminoglicosídeo pouco absorvido; amebicida luminal [Externo: monografia Drugs]	[Externo: monografia Drugs] 25–35 mg/kg/dia VO em 3 doses, por 5–10 dias (geralmente 7), com a refeição	Após o amebicida tecidual, na amebíase intestinal	[Externo: monografia Drugs] náusea, cólicas e diarreia (acima de 3 g/dia); nefro e ototoxicidade se absorvida	Cautela em lesões ulceradas intestinais (absorção); [Externo] pode ser escolha na gestação
Loperamida	Antimotilidade (opioide periférico) [Externo: farmacologia de referência]	4 mg inicial, 2 mg após cada evacuação não formada, por <2 dias, máx. 16 mg/dia [Abund.]; sem receita: máx. 8 mg/dia [Externo: PDR]	Diarreia sem sangue e sem febre; evitar em disenteria sem antibiótico (Grade 2C)	[Externo: PDR] constipação, náusea, dor; íleo e megacólon tóxico; arritmia com doses acima da recomendada. [Abund.] mascara perda de volume	Advertir sobre dose máxima [Abund.]; sinais de distensão abdominal

Fármaco	Classe / mecanismo de ação	Posologia completa	Indicação específica nesta doença	Efeitos adversos principais	Monitorização necessária
Difenoxilato (Lomotil)	Antimotilidade opioide [Externo: farmacologia de referência]	5 mg (2 comprimidos) 4×/dia por <2 dias [Abund.]	Alternativa à loperamida	Efeitos opioides centrais ou colinérgicos [Abund.]	Não informado na fonte
Subsalicilato de bismuto	Antissecretor/salicilato [Externo: farmacologia de referência]	30 mL ou 2 comprimidos a cada 30 min × 8 doses [Abund.]	Febre/disenteria quando loperamida é evitada	Toxicidade por salicilato (aspirina, gestantes) [Abund.]	Monitorar a dose total, sobretudo em gestantes [Abund.]
Racecadotril	Inibidor de encefalinase; antissecretor [Abund.]	[Externo: Fischbach et al., Front Med, 2016] 100 mg VO 3×/dia (adultos)	Sintomático, se disponível (não nos EUA)	[Externo] prurido; menos constipação e distensão que loperamida; cautela com sacarose	Não informado na fonte
Ondansetrona	Antagonista 5-HT3; antiemético [Externo: farmacologia de referência]	[Externo: WikEM] 4–8 mg a cada 4 h, máx. 24 mg/dia; dar antes e iniciar SRO ~15 min depois [TRO]	Vômitos que limitam a SRO (evidência pediátrica) [TRO]	[Externo: WikEM] constipação, cefaleia; prolongamento do QT, torsades; síndrome serotoninérgica	Contraindicada em QT longo congênito [Externo]
Zinco	Micronutriente [Externo: farmacologia de referência]	Crianças >6 meses em países com deficiência prevalente [TRO]. [Externo: Ministério da Saúde] 20 mg/dia por 10–14 dias (>6 meses)	Diarreia pediátrica em áreas de alta deficiência de zinco	Não informado na fonte	Não informado na fonte
Probióticos	—	—	**Não recomendado** — uso em adultos com gastroenterite infecciosa não comprovado [Abund.]	—	—
Antibiótico de rotina na diarreia aquosa sem gravidade	—	—	**Não recomendado** (Grade 1B) — risco supera benefício [Abund.]	Toxicidade, resistência, *C. difficile*	—
Antibiótico (em especial beta-lactâmico) em STEC	—	—	**Não recomendado** — não reduz sintomas e se associa a SHU [Abund.]	SHU	Teste toxina Shiga antes de tratar
Antibiótico no portador assintomático de Salmonella	—	—	**Não recomendado de rotina** — erradica mal, prolonga carriage e seleciona resistência; exceção por saúde pública: cipro 500 mg 2×/dia ou levo 500 mg/dia por 4 semanas [Salm.]	Resistência	3 coproculturas em 1 semana, ≥1 semana após o antibiótico [Salm.]
SRO à base de polímeros / com aminoácidos	—	—	**Não recomendada** como inicial — não superior à SRO padrão e mais cara [TRO]	—	—
Soluções caseiras, caldo de galinha, bebidas esportivas, sucos	—	—	**Não recomendados** para reidratar na desidratação; suco de maçã diluído 1:1 é opção só para crianças com gastroenterite leve sem desidratação [TRO]	Diarreia osmótica; hipernatremia (caldo)	—

Fármaco	Classe / mecanismo de ação	Posologia completa	Indicação específica nesta doença	Efeitos adversos principais	Monitorização necessária
Outros citados sem posologia na fonte	—	Tratamento empírico para *C. difficile* (suspeita alta, antibiótico prévio); antibióticos ativos contra *Listeria* (gestante febril); tratamento empírico para clamídia e gonorreia (proctite em HSH); fluoroquinolona IV (salmonelose grave) [Abund.][Salm.]	Conforme tópicos específicos do UpToDate	Não informado na fonte	Não informado na fonte

8. Prevenção, prognóstico e seguimento

8.1 Prevenção

Nível	Medidas
Primária	Lavagem de mãos com sabão; água potável; manuseio e processamento seguros dos alimentos; aleitamento materno; descarte adequado de excretas; controle de moscas [Limit.]. Vacina contra rotavírus (reduziu a doença onde há vacinação infantil); duas vacinas orais de células inteiras inativadas contra cólera aprovadas internacionalmente e pré-qualificadas pela OMS (a bivalente de menor custo compõe o estoque global desde 2013; a monovalente foi usada sobretudo por viajantes); vacinas candidatas contra Shigella em teste [Limit.][Abund.]
Secundária (diagnóstico precoce)	Reconhecer gravidade e risco cedo; reidratar logo; testar fezes quando há indicação; notificar surtos. **Não há eficácia comprovada em rastrear manipuladores de alimentos assintomáticos**; trabalhadores sintomáticos (alimentos, saúde, creche) devem ficar em casa; algumas jurisdições exigem coprocultura(s) negativa(s) antes do retorno — seguir a saúde pública local [Salm.][Abund.]
Terciária (evitar complicações e recidivas)	Não tratar STEC com antibiótico (evita SHU); tratar salmonelose de alto risco (evita bacteremia/foco endovascular); duração prolongada em imunossuprimidos (evita recidiva); suporte nutricional. Em cuidadores/profissionais que atendem imunossuprimidos, erradicação do portador pode ser tentada com saúde pública [Salm.]

8.2 Prognóstico

- **História natural:** a maioria é autolimitada e se resolve com suporte [Abund.]. Na salmonelose: febre em 48–72 h, diarreia em 4–10 dias; mediana de 5 semanas de excreção intermitente; mortalidade de 0,5–1% em surtos de *S.* Enteritidis (provável superestimativa); <5% de bacteremia [Salm.].
- **Letalidade de epidemias (Tabela 2, [Limit.]):** disenteria por Shigella — 10–20% sem tratamento e 5% com tratamento; cólera — 40% sem tratamento e <1% com tratamento. O prognóstico depende, antes de tudo, de reposição de volume e de acesso a tratamento.
- **Portador crônico** (>1 ano de excreção): <1% após Salmonella não tifoide (0,2–0,6% em um estudo; ~2,5% em <5 anos), mais comum com anormalidades biliares/litíase; para *S. typhi*, 2–5% [Salm.].
- **Fatores de pior prognóstico:** hipovolemia grave, extremos de idade, imunossupressão, HIV mal controlado, doença vascular/prótese (Salmonella invasiva), sorotipos invasivos (*S.* Choleraesuis, *S.* Heidelberg, *S.* Dublin) [Salm.]. Escores prognósticos: não informado na fonte.
- **Sequelas pós-infecciosas:** artrite reativa, síndrome de Guillain-Barré (*C. jejuni*), SHU, má absorção secundária de lactose; sintomas pós-infecciosos podem exigir manejo multifacetado [Limit.][Abund.].

8.3 Seguimento

- Se a diarreia resolve ou responde rápido: nenhum exame ou tratamento adicional; **coprocultura de controle não é necessária**, mesmo se a inicial foi positiva, salvo exigência ocupacional/de saúde pública [Abund.][Salm.].
- Se persistir: ampliar a busca por patógeno tratável (parasitas, *C. difficile*) ou por causa não infecciosa (DII, isquemia, medicamentos, doença do enxerto contra o hospedeiro) [Abund.].
- **Racional mecanístico da recidiva da salmonelose:** imunocomprometidos mantêm infecção persistente se tratados <10 dias (em estudo retrospectivo de pacientes com câncer, a recidiva ocorreu só em tratados por <10 dias) — por isso ≥14 dias [Salm.].
- Coprocultura de seguimento só em recidiva/persistência ou paciente de alto risco (quimioterapia, transplante, HIV mal controlado, recidiva prévia, prótese valvar): ≥1 semana após o antibiótico e ≥1 mês após o início; três amostras com ≥24 h de intervalo (uma cultura negativa não garante); após erradicação de portador, três coproculturas ao longo de 1 semana [Salm.].
- Creche: retorno quando as fezes ficam contidas na fralda (ou continência, se treinada) e com frequência ≤2 evacuações acima do habitual [Salm.].

8.4 Comunicação com o paciente

- **Diagnóstico e plano:** a maioria das diarreias é infecciosa e passa sozinha; o tratamento é repor líquidos (SRO pronta); antibiótico nem sempre ajuda e pode piorar.
- **Adesão:** tomar SRO em pequenos goles, após cada evacuação; manter alimentação; evitar antidiarreico se há febre ou sangue; não exceder a dose máxima de loperamida (16 mg/dia).
- **Sinais de retorno:** sangue nas fezes, febre persistente, vômitos que impedem beber, pouca urina/tontura, dor abdominal intensa, diarreia >7–14 dias [Abund.][Limit.].

- **Higiene e trabalho:** lavar as mãos com sabão; manipuladores de alimentos, profissionais de saúde e de creche ficam afastados enquanto sintomáticos; seguir a regra local para retorno [Salm.].

Fontes (por nome): UpToDate, *Approach to the adult with acute diarrhea in resource-abundant settings*; UpToDate, *Approach to the adult with acute diarrhea in resource-limited settings*; UpToDate, *Nontyphoidal Salmonella: Gastrointestinal infection and asymptomatic carriage*; UpToDate, *Oral rehydration therapy*. **Fontes externas consultadas:** Ministério da Saúde (Brasil), cartaz *Manejo do paciente com diarreia*; Fischbach et al., *Front Med* 2016 (racecadotril); PDR (loperamida); WikEM (ondansetrona); monografia Drugs (paromomicina).